Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara Cível da Comarca de Serra Talhada

R CABO JOAQUIM DA MATA, S/N, Forum Dr. Clodoaldo Bezerra de Souza e Silva, TANCREDO NEVES, SERRA TALHADA - PE - CEP: 56909-115 - F:(87) 39293586

Processo nº **0006712-33.2023.8.17.3370**

AUTOR(A): KARINE MIKAELLY DE SA MAGALHAES

RÉU: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

S E N T E N Ç A

A Sr.ª **KARINE MIAELLY DE SÁ MAGALHÃES**, dados qualificativos expressos na exordial, ajuizou a presente ação ordinária contra a **UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, igualmente identificado, alegando, em suma, que:

> "[...].
>
> Há mais de 15 (quinze) anos, a Promovente, é acometida por quadro clínico de longas crises de dores abdominais e generalizadas, lesões na pele, além de distúrbios de sono e ansiedade, demandando, não só de frequente acompanhamento médico especialista, mas, também, de longos períodos de internação, para receber os cuidados necessários.
>
> [...].
>
> Nesse cenário de dor constante e, aparentemente, incurável, a Autora desenvolveu quadro de depressão maior e recorrente (CID F33-3), com a presença de ideações suicidas, sendo constantemente acompanhada por tratamento psicológico e psiquiátrico:
>
> [...].
>
> Após anos de sofrimento físico e psíquico, com longos históricos de consultas, internações e medicamentos, em maio de 2023, a Autora recebeu o diagnóstico de dor crônica intratável (CID R521), sendo, ainda, portadora de porfiria (CID E80), doença rara causadora de incessante dor abdominal e sintomas neurológicos:
>
> [...].
>
> O mais agravante é que a doença enfrentada é incurável, de modo que, existem apenas medicamentos paliativos que melhoram a qualidade de vida da paciente.
>
> A parte promovente anexa a presente inúmeros laudos médicos que comprovam histórico clínico e as várias enfermidades que acompanham a sra. Karine.
>
> [...].
>
> Nesse ínterim, ante aos diagnósticos e após utilizar inúmeros medicamentos sem qualquer sucesso ao longo de quinze anos, houve a indicação médica e pedido de liberação para tratamento à base de canabidiol.
>
> Conforme laudo médico emitido em 24/05/2023, de lavra do Dr. Danuzio Oliveira (CRM/PE 17.564, RQE 2138), especialista em Neurologia Clínica, detalha documentalmente essa situação, receitando, ao fim, o uso do canabidiol:
>
> [...].
>
> A Promovente possui plano de saúde ativo junto a empresa UNIMED:
>
> [...].
>
> Entretanto, de forma totalmente desrespeitosa e absurda, em cristalina inobservância ao quadro clínico da Autora e indicações médicas, a Promovida indeferiu o reembolso, sob o pretexto que de "o medicamento não se enquadra nas regras de reembolso previstas em contrato. Outrossim, (...) o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado em coberturas obrigatórias:
>
> [...]".

Em razão desses fatos, a parte demandante requereu *(i)* a concessão dos benefícios da justiça gratuita; *(ii)* o deferimento de tutela de urgência para que o plano de saúde promovido lhe forneça ou custei desde logo o medicamento à base de "canabidiol"; e, ao final, a procedência do pedido para que haja *(iii)* a conformação da tutela de urgência.

Com a petição inicial foram apresentados documentos.

Proferiu-se decisão concedendo os benefícios da justiça gratuita e indeferindo o pedido de tutela de urgência (ID 151741855). Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento (processo nº 0026363-39.2023.8.17.9000), tendo o E. TJPE deferido o pedido de tutela recursal (ID 176203444).

Regularmente citada, a parte requerida apresentou defesa, em forma de contestação (ID 155246681). No mérito, defendeu basicamente o seguinte:

> "[...].
>
> No caso em tela, o medicamento indicado à Requerente, além de ser adquirido em farmácias comuns, é de uso exclusivamente domiciliar, de administração pelo próprio paciente e sem a necessidade de supervisão por profissional de saúde.
>
> Daí porque, não há como impor à Contestante o dever de custeio, seja pela expressa exclusão legal, seja pela previsão do artigo 17 da Resolução Normativa nº 465 da ANS (Rol de Procedimentos) e da cláusula 19, itens "a" e "k" do contrato firmado entre as partes. Confira-se:
>
> [...]."

A parte ré solicitou a improcedência dos pedidos e juntou documentos.

A parte autora se manifestou a respeito da peça de bloqueio (ID 174587288).

Este é o relatório.

Tudo bem visto e ponderado, **DECIDO**.

Cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento abreviado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois desnecessária a dilação probatória para a oferta da prestação jurisdicional.

Por oportuno, cabe esclarecer que *"Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC"* (Enunciado n° 27 da I Jornada de Direito Processual Civil realizado STJ/CJF).

Outrossim, *"Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação"* (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2012878 - MG).

Não há questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação.

Com isso, passo a enfrentar o mérito.

Sem maiores delongas, registro, desde logo, que o pedido formulado na exordial deve ser julgado **improcedente**.

Explico.

Como se pode notar, a parte autora foi diagnosticada *"dor crônica intratável (CID R521)"* e *"porfiria (CID E80)"*, e, por isso, consoante os médicos assistentes, precisa usar medicamentos à base de "canabidiol".

A seguradora ré negou a cobertura sob o argumento de que por força do art. 10, IV, da Lei n° 9.656/1998 não pode ser obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar.

Pois bem.

O art. 10, IV, da Lei n° 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) **exclui expressamente**, no âmbito da Saúde Suplementar, a obrigatoriedade de *"fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12"*.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento **atual** de que os Planos de Saúde/Seguros Saúde (Saúde Suplementar) **podem excluir** de suas obrigações contratuais o fornecimento de medicamentos para **tratamento domiciliar**, **exceto** os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Reforçando este posicionamento, colaciono os seguintes julgados do STJ:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOME CARE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. **2. No que diz respeito ao medicamento de uso domiciliar, a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).** (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Viilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 3. Agravo interno improvido."

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.019.333/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023) (g.n.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. **1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim**. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). **3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.** 4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 6. Agravo interno não provido."

(STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.) (g.n.)

Ainda de acordo com o STJ, *"[...]. o medicamento para tratamento domiciliar de que trata o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 é* ***aquele prescrito pelo médico e que deve ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, sem necessidade de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado, isto é, o medicamento diretamente adquirido nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar"*** (AgInt no AREsp n. 2.310.638/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023 [g.n.]).

Nada impede, obviamente, que seja realizada a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde ***(i)*** por liberalidade; ***(ii)*** por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou; ***(iii)*** mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.

Na situação em apreço, contudo, **há expressa disposição contatual excluindo** o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar (ID 155248240 - Pág. 12).

Deste modo, considerando que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar e não é enquadrável como *"antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim"*, mostra-se **inviável** acolher o pleito inicial.

Consigno, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante art. 489, §1º, IV, do CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça[1] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2024/0724/260724/Senten%C3%A7a.PRO.parcial.plano%20de%20sa%(decidiu que *"[...]. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...]"*.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para **JULGAR IMPROCEDENTE** o pedido formulado na petição inicial.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os parâmetros estipulados nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, **atentando-se na execução para a regra do art. 98, § 3º do CPC, tendo em vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita**.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em sendo interposto recurso de **APELAÇÃO**, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, **INTIME-SE** o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do CPC), **INTIME-SE** a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso sejam apresentadas contrarrazões, em sendo suscitadas preliminares, **INTIME-SE** o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca das referidas questões.

Após o prazo, com ou sem resposta, ex vi do disposto no § 3º do art. 1.010 do CPC, **REMETAM-SE** os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, independentemente do juízo de admissibilidade.

Depois de cumpridas todas as disposições contidas nesta sentença, sem novos requerimentos, **arquive-se**.

Serra Talhada/PE, data conforme o registro da assinatura eletrônica.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres

Juiz de Direito

---

[1] (file:///F:/2.1.%20Trabalho%20-%20Feito/2.1.%20Serra%20Talhada/1VCST/2024/0724/260724/Senten%C3%A7a.PRO.parcial.plano%20de%20sa%

EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

Assinado eletronicamente por: DIOGENES PORTELA SABOIA SOARES TORRES
26/07/2024 12:51:37
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 177047693

24072612513712000000172791491

IMPRIMIR GERAR PDF